

CURSO DE MEDICINA LEGAL APLICADA À PSIQUIATRIA FORENSE

Imputabilidade Penal e Capacidade Civil

Apostila robusta para estudo e uso prático em perícias psiquiátricas
— baseada no tema do Capítulo 18 de Genival Veloso de França

Autor do material: Diabinho / OpenClaw para Dr. Luís Henrique B. Gomes

Finalidade: estudo, consulta rápida, estruturação de raciocínio pericial, elaboração de laudos e respostas a quesitos.

Observação: material autoral e sintético. Não reproduz o livro; organiza e operacionaliza os conceitos para prática médico-pericial.

Sumário

1. Objetivo do curso
2. Mapa geral: penal versus civil
3. Conceitos fundamentais
4. Imputabilidade penal: raciocínio pericial
5. Capacidade civil: raciocínio pericial
6. Modificadores biopsicossociais
7. Transtornos mentais e impacto forense
8. Entrevista pericial dirigida
9. Exame do estado mental forense
10. Simulação, dissimulação e inconsistências
11. Modelos de conclusão
12. Quesitos frequentes
13. Casos práticos comentados
14. Checklists finais

1. Objetivo do curso

Este curso foi construído para transformar o tema “imputabilidade penal e capacidade civil” em ferramenta prática de trabalho para o psiquiatra perito e assistente técnico.

Ao final, você deve ser capaz de:

- diferenciar imputabilidade, imputação, inimputabilidade e semi-imputabilidade;
- avaliar capacidade civil por domínios funcionais;
- separar diagnóstico psiquiátrico de conclusão médico-legal;
- conduzir entrevista dirigida para perícias penais e cíveis;
- estruturar exame do estado mental com finalidade forense;
- responder quesitos de forma objetiva e tecnicamente defensável;
- redigir conclusões proporcionais aos achados.

Regra de ouro: diagnóstico psiquiátrico não decide imputabilidade nem capacidade civil. O que decide é a relação entre transtorno, discernimento, autodeterminação, funcionalidade e o ato juridicamente relevante.

2. Mapa geral: penal versus civil

Aspecto	Perícia penal	Perícia civil
Pergunta central	No momento do fato, o examinado entendia a ilicitude e podia se autodeterminar?	O examinado possui capacidade para atos da vida civil? Quais atos?
Temporalidade	Geralmente retrospectiva: momento do fato.	Atual ou retrospectiva, conforme ato civil questionado.
Foco	Responsabilidade penal.	Autonomia, proteção, apoio e curatela proporcional.
Conclusões possíveis	Imputável, semi-imputável, inimputável ou inconclusivo.	Capaz, capaz com apoio, incapaz parcialmente, incapaz amplamente ou inconclusivo.
Erro comum	Concluir pela existência do diagnóstico, sem analisar o momento do fato.	Transformar diagnóstico em incapacidade global.

Uso prático: antes de escrever qualquer laudo, defina o ato juridicamente relevante. Sem isso, a análise fica genérica e vulnerável.

3. Conceitos fundamentais

3.1 Imputabilidade penal

É a capacidade psíquica de ser responsabilizado penalmente por uma conduta. Envolve dois eixos:

- **cognitivo:** entender a natureza do ato, a realidade, a ilicitude e consequências;
- **volitivo:** determinar-se conforme esse entendimento, inibir impulsos e escolher conduta alternativa.

3.2 Imputação

Imputabilidade é a capacidade penal abstrata; imputação é a atribuição concreta de responsabilidade por determinado fato. O perito não julga a imputação, mas fornece elementos sobre a capacidade mental no momento relevante.

3.3 Inimputabilidade

Requer demonstração de comprometimento total da capacidade de entendimento e/ou autodeterminação, relacionado a transtorno mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado, presente no momento do fato.

3.4 Semi-imputabilidade

Ocorre quando há redução relevante, mas não abolição completa, da capacidade de entendimento ou autodeterminação. Deve ser fundamentada em sintomas, grau de prejuízo e nexo com a conduta.

3.5 Capacidade civil

É a aptidão para praticar atos da vida civil. Na avaliação psiquiátrica, exige análise de quatro componentes decisórios:

1. compreensão;
2. apreciação da própria situação;
3. raciocínio sobre riscos, benefícios e alternativas;
4. expressão de escolha estável.

4. Imputabilidade penal: raciocínio pericial

A avaliação penal precisa reconstruir o estado mental no momento do fato. O diagnóstico atual ajuda, mas não substitui a reconstrução retrospectiva.

4.1 Perguntas essenciais

- ☐ Qual era o diagnóstico provável no momento do fato?
- ☐ Havia sintomas ativos?
- ☐ O sintoma tinha relação funcional com a conduta?
- ☐ O examinado compreendia a realidade?
- ☐ Compreendia a ilicitude?
- ☐ Conseguia escolher conduta alternativa?
- ☐ Houve planejamento, fuga ou ocultação?
- ☐ Houve uso de substâncias?
- ☐ Há documentos contemporâneos?

4.2 Dados de maior valor

- prontuários próximos ao fato;
- relatos familiares e testemunhais;
- boletim de ocorrência e depoimentos;
- imagens, mensagens e áudios;
- exames toxicológicos;
- histórico de internação e tratamento;
- comportamento antes, durante e depois do fato.

Cuidado: fuga ou ocultação sugerem crítica preservada, mas não decidem sozinhas. Um paciente psicótico também pode fugir por medo delirante.

5. Capacidade civil: raciocínio pericial

A capacidade civil deve ser analisada por domínio. A pergunta nunca deve ser apenas “é capaz ou incapaz?”, mas “capaz para quê?”.

5.1 Domínios a avaliar

- administração de renda e patrimônio;
- contratos, empréstimos e compra/venda de bens;
- outorga de procuração;
- consentimento para tratamento;
- proteção contra abuso/manipulação;
- decisões familiares, afetivas e existenciais;
- autonomia doméstica e cuidado pessoal.

5.2 Curatela proporcional

A curatela deve ser necessária, proporcional, delimitada e menos restritiva possível. Sempre que viável, preservar direitos existenciais, vínculos afetivos, convivência social e escolhas cotidianas.

Formulação útil: “Sugere-se curatela limitada aos atos patrimoniais e negociais complexos, preservando-se direitos existenciais e decisões cotidianas simples.”

6. Modificadores biopsicossociais

São fatores que contextualizam imputabilidade e capacidade civil, mas não funcionam como conclusões automáticas.

6.1 Idade

Em adolescentes, considerar maturidade, desenvolvimento moral, impulsividade, ambiente e eventual transtorno mental. Em idosos, pensar em demência, delirium, depressão, vulnerabilidade a golpes e capacidade para atos patrimoniais.

6.2 Deficiências sensoriais

Surdez, mutismo ou cegueira não equivalem a incapacidade mental. Avaliar comunicação, compreensão, escolarização, acesso à informação e necessidade de adaptação.

6.3 Estados emotivos

Emoções intensas podem influenciar a conduta, mas não excluem automaticamente imputabilidade. Verificar intensidade, duração, planejamento, consciência, crítica e nexos com transtorno mental.

6.4 Substâncias

Diferenciar intoxicação voluntária comum, dependência, abstinência, delirium, psicose induzida e intoxicação patológica. A presença de álcool ou droga não resolve o caso automaticamente.

6.5 Deficiência intelectual

Não avaliar apenas QI. O funcionamento adaptativo, a sugestibilidade, a compreensão de consequências e a capacidade de consentimento são decisivos.

7. Transtornos mentais e impacto forense

Quadro	Penal	Civil	Cuidado principal
Esquizofrenia/psicose	Pode abolir/reduzir capacidade se sintomas ativos estiverem ligados ao fato.	Pode comprometer atos complexos, dependendo de crítica e funcionalidade.	Demonstrar nexos entre sintoma e conduta.
Transtorno bipolar	Mania/misto/psicose podem afetar entendimento ou autodeterminação.	Mania pode invalidar atos patrimoniais no período.	Documentar episódio e temporalidade.
Transtorno delirante	Relevante quando o ato decorre do sistema delirante.	Pode afetar decisões relacionadas ao tema delirante.	Verificar vínculo entre delírio e ato.
Transtornos de personalidade	Geralmente não excluem imputabilidade por si só.	Raramente geram incapacidade global isolada.	Evitar moralização.
Demências	Podem afetar imputabilidade conforme gravidade e momento.	Frequentemente relevantes para curatela.	Avaliar funcionalidade por domínio.
Uso de substâncias	Depende de tipo, voluntariedade e estado mental.	Pode afetar gestão se dependência grave.	Diferenciar intoxicação comum de psicose/delirium.

8. Entrevista pericial dirigida

8.1 Penal — reconstrução do momento do fato

- ☐ O que ocorreu nos dias anteriores?
- ☐ Havia sintomas psicóticos, afetivos, dissociativos ou confusionalidade?
- ☐ Houve uso de álcool/drogas?
- ☐ O ato foi planejado?
- ☐ O examinado sabia que era proibido?
- ☐ Conseguia pensar em não fazer?
- ☐ Tentou fugir ou ocultar?
- ☐ Como explicou o fato depois?

8.2 Civil — quatro componentes decisórios

- ☐ Compreende o processo e o ato discutido?
- ☐ Reconhece que a situação se aplica a si?
- ☐ Compara riscos, benefícios e alternativas?
- ☐ Expressa escolha estável?
- ☐ Administra dinheiro e medicações?
- ☐ É vulnerável a manipulação?
- ☐ Há apoio familiar confiável?

9. Exame do estado mental forense

Além do exame psiquiátrico habitual, enfatizar:

- atitude frente à perícia;
- coerência narrativa;
- orientação e atenção;
- memória recente e remota;
- pensamento formal e conteúdo delirante;
- alucinações;
- humor, afeto e impulsividade;
- crítica e insight;
- julgamento;
- sugestionabilidade;
- capacidade decisória observável;
- inconsistências entre relato, exame e documentos.

10. Simulação, dissimulação e inconsistências

Simulação

Produção ou exagero intencional de sintomas para ganho externo.

Dissimulação

Ocultação de sintomas ou prejuízos, geralmente para parecer capaz, evitar internação ou evitar curatela.

Inconsistência

Inconsistência não é sinônimo de simulação. Pode ocorrer por psicose, demência, baixa escolaridade, ansiedade, trauma, vergonha ou má compreensão.

Formulação prudente: “Foram observadas inconsistências entre relato, documentos e exame, as quais reduzem a confiabilidade de determinados dados e exigem cautela interpretativa. Tais inconsistências, isoladamente, não permitem afirmar simulação sem elementos adicionais.”

11. Modelos de conclusão

11.1 Penal — imputabilidade preservada

O examinado apresenta diagnóstico de [DIAGNÓSTICO], contudo os elementos clínicos e documentais disponíveis não demonstram que, ao tempo do fato, tal condição tenha abolido ou reduzido de modo juridicamente relevante sua capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar conforme esse entendimento.

11.2 Penal — semi-imputabilidade

O examinado apresenta [DIAGNÓSTICO], com evidências de comprometimento parcial de [ENTENDIMENTO/AUTODETERMINAÇÃO] ao tempo do fato, relacionado a [SINTOMAS]. Tal comprometimento não aboliu completamente sua capacidade penal, mas a reduziu de forma relevante.

11.3 Penal — inimputabilidade

O examinado apresenta [DIAGNÓSTICO], com elementos indicativos de que, ao tempo do fato, encontrava-se em estado de [DESCREVER ESTADO PSICOPATOLÓGICO], o qual comprometeu de forma total sua capacidade de [ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO / DETERMINAR-SE].

11.4 Civil — curatela parcial

O examinado apresenta [DIAGNÓSTICO], com prejuízos em [DOMÍNIOS], repercutindo especialmente sobre [ATOS]. Preserva, entretanto, capacidade para [ATOS PRESERVADOS]. Recomenda-se medida proporcional e limitada aos atos [ESPECIFICAR].

12. Quesitos frequentes

Quesito: O periciando é portador de doença mental?

Resposta-modelo: Sim/Não. Com base em entrevista, exame e documentos, o periciando apresenta quadro compatível com [DIAGNÓSTICO], fundamentado em [ACHADOS].

Quesito: A doença mental compromete sua imputabilidade?

Resposta-modelo: O diagnóstico, isoladamente, não permite concluir sobre imputabilidade. Deve-se avaliar se, ao tempo do fato, havia prejuízo da capacidade de entendimento e/ou autodeterminação.

Quesito: É capaz para os atos da vida civil?

Resposta-modelo: A capacidade civil deve ser analisada por domínio funcional. No caso concreto, há preservação de [DOMÍNIOS] e prejuízo em [DOMÍNIOS], recomendando-se [CONCLUSÃO].

Quesito: Há necessidade de curatela?

Resposta-modelo: A necessidade de curatela depende de prejuízo funcional concreto e risco associado. Se indicada, deve ser proporcional e limitada aos atos efetivamente comprometidos.

13. Casos práticos comentados

Caso 1 — Psicose e agressão

Indivíduo com esquizofrenia sem tratamento agride pessoa que acreditava, de modo delirante, representar ameaça. Familiares relatam delírios persecutórios ativos antes do fato.

Raciocínio: verificar nexos entre delírio e conduta, presença de psicose ativa, crítica, planejamento e comportamento posterior.

Caso 2 — Mania e contrato

Paciente em mania doa bens, contrai empréstimos e compra veículos, com grandiosidade e internação logo após.

Raciocínio: capacidade civil retrospectiva; avaliar juízo crítico, desinibição, consequência patrimonial e nexos temporais.

Caso 3 — Demência e curatela

Idoso com perda de memória, vulnerabilidade a golpes e dificuldade bancária, mas preserva preferências pessoais.

Raciocínio: curatela proporcional para atos patrimoniais, preservando direitos existenciais.

Caso 4 — Personalidade e fraude

Indivíduo com traços antissociais comete fraude planejada e tenta ocultar provas.

Raciocínio: diagnóstico de personalidade não reduz imputabilidade automaticamente; planejamento e ocultação sugerem entendimento preservado.

14. Checklists finais

14.1 Antes de concluir perícia penal

- ☐ Identifiquei o momento do fato?
- ☐ Reconstruí sintomas naquele momento?
- ☐ Analisei entendimento da ilicitude?
- ☐ Analisei autodeterminação?
- ☐ Demonstrei nexos entre transtorno e conduta?
- ☐ Considerei substâncias?
- ☐ Avaliei planejamento/fuga/ocultação?
- ☐ Declare limitações?

14.2 Antes de concluir perícia civil

- ☐ Defini o ato civil discutido?
- ☐ Avaliei compreensão, apreciação, raciocínio e escolha?
- ☐ Analisei funcionalidade financeira?
- ☐ Avaliei vulnerabilidade a abuso?
- ☐ Delimitei atos preservados e comprometidos?
- ☐ Considerei medida menos restritiva?
- ☐ Evitei curatela genérica?

Frase final: a boa perícia psiquiátrica não pergunta apenas “qual é o diagnóstico?”. Pergunta: “que função mental foi comprometida, em que grau, em qual momento, com que nexos com o ato e com quais consequências jurídicas possíveis?”.

Material elaborado para estudo e aplicação médico-pericial. Revisão técnica e julgamento pericial final cabem ao médico responsável.